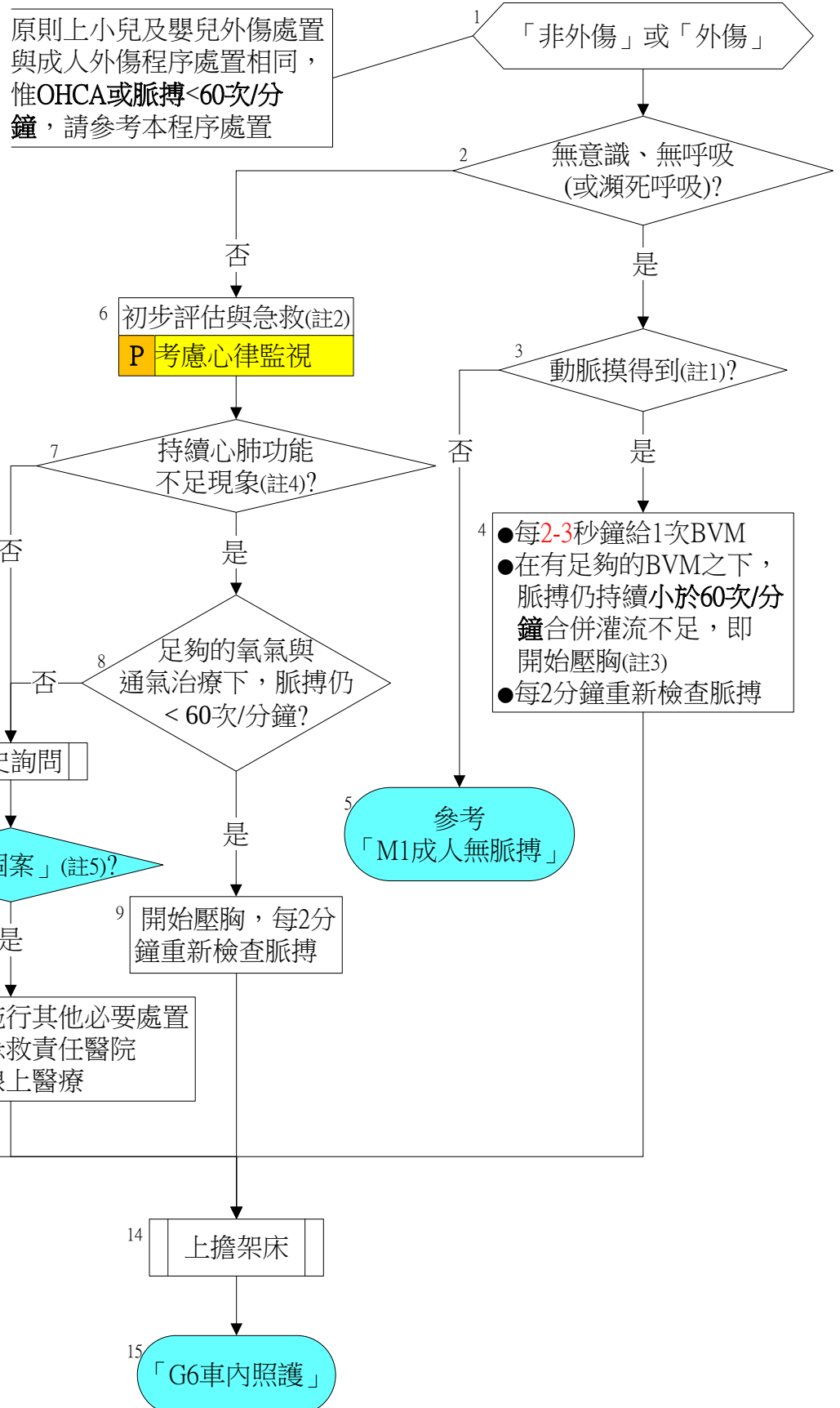


S8 小兒通用

程 序



要 旨

- 一、本程序適用於小於18歲或尚未出現第二性徵的兒童傷病患（新生兒除外）。若8歲以上或體型較大（目測可能超過25公斤以上）之兒童，可依成人相關程序處理。
- 二、小兒急救中，若持續出現心肺功能不足現象，應以提高氧氣濃度及改善通氣狀況為優先處理目標。

註 解

註1>

1歲以上檢查頸動脈、1歲以下檢查肱動脈或股動脈。

註2>

兒童的急救須特別注意「呼吸問題」。包括：氧氣濃度、呼吸道暢通、必要時給予輔助呼吸道及BVM。

註3>

兒童CPR急救步驟，請參考「[M1](#)成人無脈搏」-「臺北市府消防局心肺復甦術摘要表」。

註4>

兒童持續心肺功能不足現象包括：

- 一、低血壓：收縮壓低於【 $70 + (2 \times \text{年齡})$ 】mmHg。(適用於1-10歲)
- 二、急性意識改變。
- 三、休克徵候。

註5>

一、兒童生命徵象正常值：

正常範圍	心跳(次/分)	呼吸(次/分)	血壓(mmHg)	體重(Kg)
嬰兒	120 ~ 160	40 ~ 60	收縮壓【 $70 + (2 \times \text{年齡})$ 】mmHg。(適用於1-10歲)	3 ~ 8
學齡前幼兒	100 ~ 120	30 ~ 60		8 ~ 20
學齡兒童	80 ~ 100	20 ~ 30		> 20

二、評估失能：

(一) 瞳孔大小、對光反應，檢查肌張力

(二) 兒童昏迷指數Pediatric Glasgow Coma Scale (P.G.C.S) 與昏迷指數Glasgow Coma Scale (G.C.S) 計分原則

給分標準	嬰兒或尚未能語言表達之兒童	已能語言表達之兒童
眼睛反應		
4	自動張開眼睛	自動張開眼睛
3	喊他才會張開眼睛	可依指示張開眼睛
2	給與疼痛刺激才會張開眼睛	給與疼痛刺激才會張開眼睛
1	給與疼痛刺激均不睜眼，都沒有反應	給與疼痛刺激均不睜眼，都沒有反應
語言反應		
5	適當的哭泣反應，會發出咕咕聲音	能正確說出單字或句子、會認出主要照顧者
4	欠安的哭泣	不適當的單字、句子
3	不適當的尖叫或哭泣	胡言亂語
2	發出呻吟	發出呻吟
1	沒有反應	沒有反應
運動反應		
6	能正常自主的運動反應	能依指示作自主的運動反應
5	能有效的除去觸摸的刺激	能指出疼痛的刺激的部位
4	對於疼痛的刺激回縮躲避	對於疼痛的刺激回縮躲避
3	對刺激，呈現上肢屈曲胸前，下肢僵硬（即去皮質姿勢）	對刺激，呈現上肢屈曲胸前，下肢僵硬（即去皮質姿勢）
2	傷病患對痛刺激，手腳呈現伸展僵直現象（即去大腦姿勢）	傷病患對痛刺激，手腳呈現伸展僵直現象（即去大腦姿勢）
1	對於疼痛的刺激沒有反應	對於疼痛的刺激沒有反應

注意：> 5 歲以上兒童評估方式與成人相同

三、評估身體：

- (一) 適當暴露與評估體溫。
- (二) 治療高/低體溫及評估危急傷口並注意兒虐之可能性。